# ĐỀ ÁN CẢI TIẾN GIƯỜNG BỆNH PHÒNG CHỐNG NGÃ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

## I, ĐẶT VẤN ĐỀ

Trượt, ngã trong bệnh viện là một vấn đề y tế công cộng chính trên thế giới. Trong bệnh viện, khoảng 3- 20% người bệnh nội trú bị trượt, ngã ít nhất một lần trong thời gian nằm viện. hậu quả của trượt, ngã có thể dẫn đến tình trạng trầm trọng và chi phí điều trị tốn kém thêm. Phòng chống trượt, ngã cho người bệnh là một ưu tiên trong An toàn người bệnhvà đây cũng là một mục tiêu quan trọng mà tổ chức y tế thế giới muốn hướng tới.

Gẫy xương hông sau trượt ngã xảy ra khoảng 90% các trường hợp. Tại Hoa Kỳ, hàng năm có đến gần 200,000 người cao tuổi gẫy xương hông vì ngã, nhiều người thiệt mạng trong khi điều trị ở Bệnh viện. Tử vong 5 năm sau thương tích lên khá cao, tới 50%, đặc biệt là ở cụ ông và khi các cụ lại có thêm vài bệnh kinh niên.

Một trong những nguy cơ gây trượt, ngã cho người bệnh hiện nay là do thiết kế giường bệnh thiếu thanh chắn an toàn.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong những năm qua đã có những trường hợp người bệnh bị trượt ngã do giường bệnh thiết kế không có thanh chắn an toàn. Năm 2018 đã có 2 trường hợp trượt, ngã xảy ra tại Trung tâm gây hậu quả tổn thương cho người bệnh, có 01 bệnh nhi bị lún sọ do ngã từ trên giường xuống đất và phải điều trị bằng phẫu thuật, 01 bệnh nhi bị gãy tay.

Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi nhận thấy cần phải có 1 giải pháp để khắc phục yếu tố mất an toàn giường bệnh do thiết kế thiếu thanh chắn an toàn này.

## II. XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN

Hiện nay tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có 268 giường bệnh nội trú trong đó có 240 giường không có thanh chắn, còn lại 28 giường có thanh chắn bao gồm cả thanh chắn đã hỏng trong đó có 19 giường tại khoa Hồi sức tích cực và 04 giường tại phòng hậu phẫu khoa Ngoại tổng hợp.

Một số khoa có nguy cơ ngã cao như khoa nội chỉ có 01 giường có thanh chắn, Khoa nhi đặc thù là bệnh nhi nhưng hiện tại toàn bộ các giường đều không có thanh chắn an toàn cho người bệnh.

## III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Quyết định 6858 QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam

Tài liệu đào tạo liên tục về An toàn người bệnh Ban hành kèm theo Quyết định số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tài liệu thực hành tốt Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh tại một số bệnh viện của PGS – TS Lương Ngọc Khuê.

## PHẦN 2: NỘI DUNG CẢI TIẾN

## I. MỤC TIÊU

### 1. Mục tiêu chung

Cải tiến các giường bệnh không có thanh chắn an toàn, để đảm bảo an toàn cho người bệnh có nguy cơ ngã, tạo cảm giác an tâm, tin tưởng cho người bệnh, phòng bệnh được sắp xếp lại gọn gàng hơn tạo môi trường sạch đẹp cho người bệnh, nhân viên y tế yên tâm điều trị người bệnhphấn cho NVYT từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

### 2. Mục tiêu cụ thể

50% số giường bệnh đượccải tiến thêm thanh chắn an toàn phòng chống ngã cho người bệnh.

Giảm số người bệnh bị ngã và tai biến do ngã do nguyên nhân giường bệnh thiếu thanh chắn an toàn

## II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. **Địa điểm:**

Phòng bệnh nội trú các khoa phòng

### 2. Thiết kế:

Hàn thêm các thanh chắn hai bên thành giường bệnh

Đặc điểm của thanh chắn:

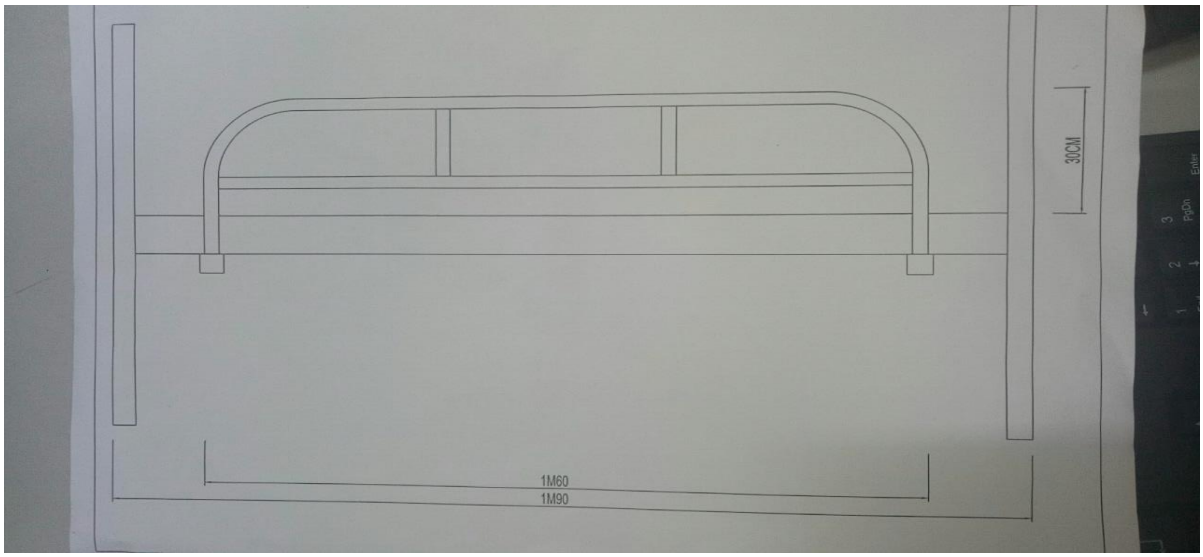
+ Các thanh chắn hai bên thành có thể nâng lên, hạ xuống được, dễ dàng cho việc vận chuyển người bệnh, người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận giường bệnh mà không bị cản trở bởi thanh chắn. Các thanh chắn ngang được thiết kế đủ hẹp tránh lọt bệnh nhi.

+ Thanh chắn làm bằng chất liệu Inox đồng bộ với các giường Inox, nhẹ, chắc chắn, không gây han gỉ, gây mất mĩ quan.

+ Chi phí bằng 1/5 khi thay thế giường mới.

+ Chiều cao 30cm, dài 1,6m, khoảng cách giữa các thanh ngang là 53cm.

**Hình ảnh: mô tả bản vẽ thiết kế thanh chắn cải tiến.**



| Hình ảnh trước khi cải tiến | Hình ảnh sau khi cải tiến |
|---|---|
|  |  |

**3. Bộ công cụ:**

Chụp ảnh trước và sau cải tiến

Theo dõi số người bệnh bị ngã do giường thiết kế thiếu thanh chắn tại trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

## III. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

**1. Phân tích vấn đề:**

Vấn đề cần phân tích ở đây là việc người bệnh bị ngã tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên gây tổn thương.

Nguyên nhân liên quan đế vấn đề chất lượng này đã được chúng tôi tìm ra do liên quan đến thiết kế giường bệnh thiếu thanh chắn an toàn.

Các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề được trình bày qua sơ đồ diễn tiến (phụ lục 2) và sơ đồ khung xương cá (phụ lục 3).

**3. Kết quả mong đợi:**

Không còn người bệnh bị ngã tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên do nguyên nhân giường bệnh thiếu thanh chắn an toàn

## IV. LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP

**1. Các nguyên nhân gốc rễ:**

Từ phân tích vấn đề nêu trên, nhóm cải tiến chất lượng chúng tôi đã đưa ra nguyên nhân gốc rễ như sau:

***Nguyên nhân người bệnh bị ngã từ trên giường xuống đất***

Giường cho bệnh nhân không có thanh chắn an toàn

**2. Các giải pháp cải tiến:**

Sau khi phân tích nguyên nhân gốc rễ, nhóm cải tiến chúng tôi đã đưa ra so sánh , lựa chọn giải pháp như sau:

| STT | Tên Giải pháp | Ưu điểm | Nhược điểm | Kinh phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thay thế giường cũ bằng giường mua mới | Đồng bộ toàn trung tâm, tất cả giường có thanh chắn an toàn | Tốn kém, chi phí cao<br>Khó thực hiện do ngân sách tốn kém<br>Lãng phí những giường bệnh hiện có<br>Thời gian chờ mua sắm lâu | 120 giường x 4.000.00 = 480.000.000 triệu đồng |
| 2 | Cải tiến thêm thanh chắn | Đỡ tốn kém, tận dụng được giường đang có<br>Khắc phục được việc ngã do giường không có thanh chắn an toàn.<br>Có thể khắc phục được trong thời gian ngắn | | 120 giường x 2 x 400 = 96.000.000 triệu đồng |

Sau khi so sánh hai giải pháp chúng tôi thống nhất chọn giải pháp cải tiến lại giường bệnh đang sử dụng để đỡ tốn kém chi phí.

## Phần 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN

**1. Tiến độ thực hiện các hoạt động cải tiến:**

Thời điểm bắt đầu: 01/06/2019.

Thời điểm kết thúc: 31/12/2019

Thời gian thực hiện cải tiến: 06 tháng.

Tiến độ chi tiết tại phụ lục 4 (sơ đồ Gantt)

**2. Nơi thực hiện:**

Phòng bệnh nội trú tại các khoa phòng

**3. Phân công nhiệm vụ**

Các nhiệm vụ chính: Các cá nhân có tên trong nội dung nào của tiến độ thực hiện tại phụ lục 5 thì thực hiện nhiệm vụ đó.

Phân công giám sát, hỗ trợ các vị trí cụ thể như sau:

| Khoa phòng | Người thực hiện | NGƯỜI GIÁM SÁT |
|---|---|---|
| Khoa nhi | Trịnh Công Viết | Nhung (QLCL),<br>Khang (K. Nhi) |
| Khoa liên chuyên khoa | | Nhung (QLCL)<br>Bs Hằng ( K. LCK) |

| | | |
|---|---|---|
| Khoa Nội tổng hợp | | Nhung (QLCL), Trang (K. Nội) |
| Khoa Ngoại tổng hợp | | Thắng (QLCL), Liền (K. Ngoại) |
| Khoa Phụ sản | | Thắng (QLCL) Trịnh Thị Liên (K. Phụ sản) |
| Khoa Truyền Nhiễm | | Nhung (QLCL), Dung (K TN) |
| Khoa Y dược cổ truyền | | Thắng ( QLCL), Mạnh (K. YDCT |

**4. Nhiệm vụ của người giám sát**

Theo dõi số người bệnh bị ngã do nguyên nhân giường thiếu thanh chắn tại khoa phòng

Theo dõi tiến độ thực hiện cải tiến giường bệnh tại khoa phòng được phân công.

Chụp ảnh trước và sau cải tiến

**5. Nguồn lực cải tiến:**

| TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanh chắn an toàn tại khoa Nhi (2 chiếc / giường) | Chiếc | 80 | 400.000 | 32.000.000 |
| 2 | Thanh chắn an toàn tại các khoa còn lại (2 chiếc / giường) | Chiếc | 160 | 400.000 | 64.000.000 |
| | **Tổng tiền** | | | | **96.000.000** |

**GIÁM ĐỐC** **NHÓM CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG**
**TRƯỞNG NHÓM**

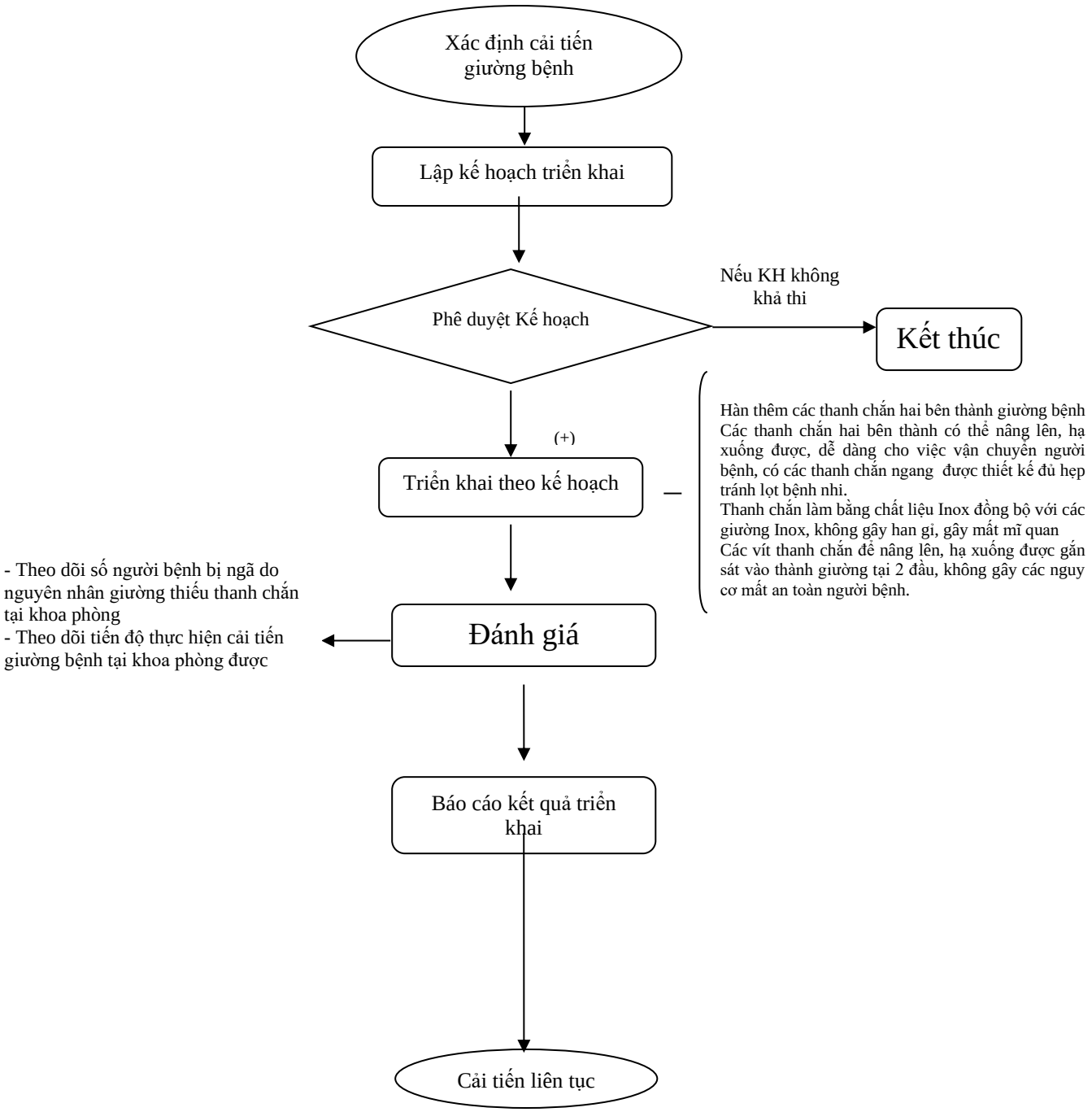
**Phạm Hồng Nhung**

**Phụ lục 1**
**Khung lựa chọn vấn đề ưu tiên**

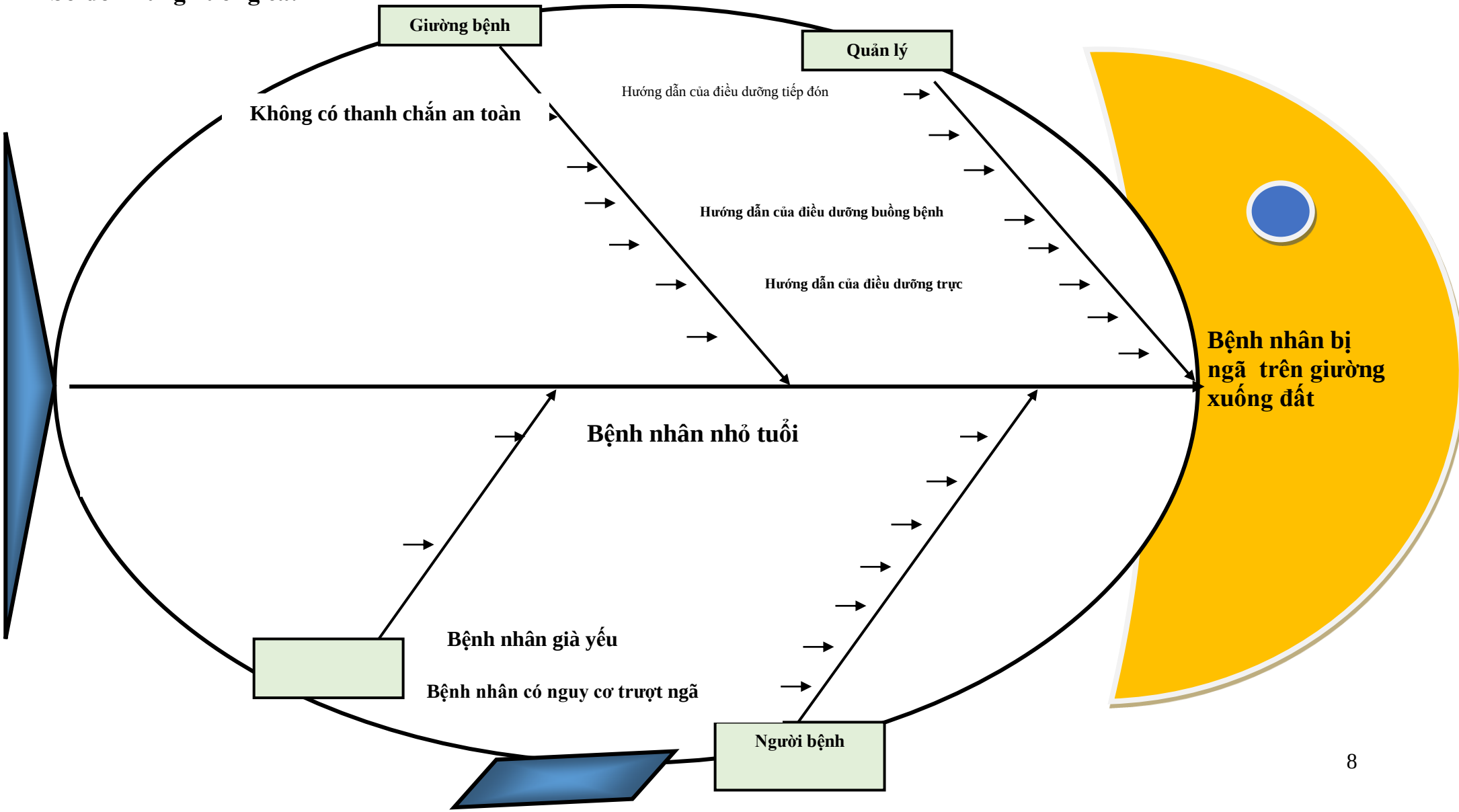
| Vấn đề | Các yếu tố | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Phạm vi | Tính nghiêm trọng | Hiệu quả | Tích điểm |
| | A | B | C | (A+2B)x C |
| Tỷ lệ giường có thanh chắn trong toàn trung tâm năm 2018 thấp | 7 | 9 | 9 | 189 |
| Tỷ lệ giường các khoa phòng không duy trì được 5s | 7 | 5 | 7 | 119 |
| Tỷ lệ báo cáo sự cố y khoa suýt xảy ra của NVYT trong Trung tâm năm 2018 còn thấp | 7 | 5 | 5 | 85 |

**Phụ lục 2**

**Sơ đồ diễn tiến quy trình triển khai thực hiện cải tiến giường bệnh chống ngã tại Trung Tâm Y tế huyện Tiên Yên.**



**Phụ lục 3**
**Sơ đồ khung xương cá:**



**Phụ lục 4 : Tiến độ thực hiện chi tiết - Sơ đồ Gantt**

| TT | Nội dung công việc | NV thực hiện | Thời gian cần thiết | Thời gian thực hiện | | | | | | | Người giám sát/chỉ đạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 | |
| 1 | Lên ý tưởng | ĐD nhung | 1 ngày | | | | | | | | Bs Yến |
| 2 | Viết đề cương đề án CTCL | ĐD Nhung | 7 ngày | | | | | | | | Bs Yến |
| 3 | Hội đồng nhận xét, góp ý | ĐD Nhung | 2 tuần | | | | | | | | Ths Việt |
| 4 | Phê duyệt đề án | Giám đốc | 1/2 ngày | | | | | | | | Ths. Việt |
| 5 | Phân công công việc cho nhóm | ĐD Nhung | 1/2 ngày | | | | | | | | Ths Việt |
| 6 | Khảo sát và Thiết kế cải tiến | Ks Viết, ĐD Nhung | 3 ngày | | | | | | | | Ths Việt |
| 7 | Làm thanh chắn cho các giường bệnh tại các khoa phòng | Ks Viết, ĐD Nhung | 2 tháng | | | | | | | | Đ D Nhung |
| 8 | Triển khai kê giường cho người bệnh | Ks Viết | 1 ngày | | | | | | | | Bs Khang |
| 9 | Báo cáo kết quả hàng tháng | ĐD Nhung | 3 ngày | | | | | | | | Bs Thắng |
| 10 | Chụp ảnh trước và sau can thiệp | ĐD nhung | 6 ngày | | | | | | | | Bs Thắng |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Tổng hợp báo cáo kết quả sau cải tiến** | **ĐD nhung** | **3 ngày** | | | | | | | | **Bs Thắng** |
| **12** | **Viết và nộp báo cáo kết thúc đợt CTCL** | **ĐD nhung** | **5 ngày** | | | | | | | | **Bs Thắng** |